



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سهام محمد محمد عوض الله

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : العياط

العنوان : =====

رقم البطاقة : 26201012100128 رقم التليفون : 01114686608

تاريخ تسجيل الإستمارة : 23-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 01-01-1962 المهنة : بدون عمل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /..... /د. /..... /د. /..... /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سهام محمد محمد عوض الله National ID: 26201012100128	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Handwritten in blue ink:
DMS
٢٠١١/٠١/٢٨
٢٠١١/٠١/٢٨



Patient's Name: SEHAM MOHAMED MOHAMED AWAD ALL
Date: 2026-04-19
Referred by: Prof.Dr. CT CAP+C
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

٣٧٧٨

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction. IV contrast was used.

FINDINGS:

Clinically reported breast carcinoma , compared to last study dated on 15/10/2025 .

(I) Chest:

- Right mastectomy with clear operative bed .
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes .
- Right upper lobe and middle lobe subpleural reticulations likely post radiotherapy.
- Clear both lung fields .no sizable pulmonary masses or consolidation patches
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size showing homogenous CT density , no focal lesions
- Patent and homogenously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Still noted right lumbar subcutaneous nodule 18 x 15 mm .

Patient's Name: SEHAM MOHAMED MOHAMED AWAD ALL
Date: 2026-04-19
Referred by: Prof.Dr. CT CAP+C
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

- Small sized right kidney 5 x 2.2 cm with compensatory hypertrophy of left kidney .
- Normal CT appearance of the pancreas, aorta and IVC.
- Normal CT appearance of the spleen .
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses .
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- No worrisome lytic or sclerotic bony lesions ..
- No vertebral structural collapse .

OPINION:.

Overall stationary course

Dr.Reham Khedr, MD

Patient's Name: SEHAM MOHAMED MOHAMED AWAAD ALLAH
Date: 2026-04-19
Referred by: Prof.Dr. MRI BRAIN + C
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MRI OF THE BRAIN WITH CONTRAST

Findings:

- Involutional brain changes in the form of prominent sub arachnoid spaces
- Few foci of altered signal intensity are seen in both frontal regions displaying high T2 & FLAIR signal intensities
- Small area of cystic encephalomalacia is noted at left cerebellar hemisphere .
- Normal size and configuration of the ventricular system with no evidence of deformity or displacement.
- No cerebellar or brain stem areas of abnormal signal intensity
- No mid line shift.
- No extra-axial collections.
- **OPINION:**

Bilateral frontal foci of lacunar infarcts , no evidence of recent ischemic insult

Left cerebellar encephalomalacia .

Dr. Reham khedr ,MD

CAIRO UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE
PATHOLOGY DEPARTMENT

Pathology No: 3267
Name: *Dr. Samar Amer*
Age: 53 Sex: female
Clinical diagnosis: Cerebellar SOL Hospital no:
Nature of specimen: Excision biopsy
Department: 25 Date: 23/05/2018

PATHOLOGY REPORT

GROSS:

Two soft tan tissue pieces: 2.5x1.5 cm & 2.5x1 cm. Totally submitted.

MICROSCOPIC:

Examination of the specimen received revealed multiple tissue fragments infiltrated by malignant epithelial growth formed of sheets, nests, cords & tubules of moderately anaplastic cells. The surrounding stroma is fibrotic. Wide areas of necrosis were detected.

DIAGNOSIS

Cerebellar SOL; excision:
Metastatic moderately differentiated adenocarcinoma.

PROF DR. MAHA MOSAAD
DR. SAMAR AMER

Dr. Samar Amer



وحدة دلائل الأورام
قسم الباثولوجيا - القصص السريرية
ب. ١٠٠٦٩١٤٩١٤٩

IMMUNOHISTOPATHOLOGY

Patient Name: سها محمد محمد

Lab.No: 2016-513

Date: 4/2016

Sex: F

Markers: ER, PR, HER 2 neu and Ki67

Procedure:

Sections were prepared from paraffin blocks treated for (ER, PR, HER 2 neu and Ki67) automatically stained in Bench mark GX (VENTANA) using view dab Detection Kit. Hematoxylin as counter stain

Result:

Examination of sections for ER and PR revealed no nuclear staining of tumour cells by chromogen

Examination of sections treated for HER2 neu revealed positive membranous staining of tumour cells by chromogen

Examination of sections treated for Ki67 revealed positive nuclear staining about 40% of tumour cells by chromogen

DIAGNOSIS:

NEGATIVE FOR ER AND PR

POSITIVE FOR HER2NEU (CLASS 3+)

HIGH PROLIFERATION INDEX

PROF. DR. SAMIA GABAL

Name : seham mohamed mohamed
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Gostaf Roseh Hospital

Date : 01-09-2025 12:02
Medical No. : 191839

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- 63-year-old lady, with history of right breast cancer, referred for metastatic workup.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- No abnormal active or cold focal bony lesions that may account for metastatic bone disease could be seen allover the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine